Guía de Tartamudez Infantil

Comprende, acompaña y ayuda a tu hijo/a. Todo lo que necesitas saber sobre la tartamudez en la infancia.

Guía gratuita · Espacio Lenguaje

Índice de contenidos

1. Qué es la tartamudez
2. Evolutiva vs que necesita intervención
3. Factores de riesgo
4. Qué hacer y qué NO hacer
5. Ejercicios de fluidez para casa
6. Sección para profesores
7. Cuándo consultar
8. Recursos y bibliografía

CAPÍTULO 1

Qué es la tartamudez

La tartamudez es mucho más que "trabarse al hablar". Vamos a entender qué ocurre realmente.

Definición

La tartamudez (o disfemia) es un **trastorno de la fluidez del habla** que se caracteriza por interrupciones involuntarias en el flujo del discurso. Estas interrupciones pueden adoptar diferentes formas según el tipo de tartamudez.

Tipos de tartamudez

Tipo	Qué ocurre	Ejemplo
Clónica	Repeticiones de sonidos, sílabas o palabras	"Pe-pe-pe-pero yo quiero ir"
Tónica	Bloqueos: el sonido no sale, hay tensión muscular	".....Pero yo quiero ir" (silencio tenso antes)
Mixta	Combinación de repeticiones y bloqueos	"Pe-pe-.....pero yo quiero ir"

Datos clave

- Afecta aproximadamente al **5% de los niños** en algún momento de su desarrollo.
- Solo el **1% de la población** mantiene la tartamudez en la edad adulta.
- Es más frecuente en **niños que en niñas** (proporción 3:1 a 4:1).
- Suele aparecer entre los **2 y los 5 años**, coincidiendo con la explosión del lenguaje.
- No está causada por nerviosismo, timidez ni problemas emocionales (aunque estos pueden empeorarla).

> **Disfluencia normal vs. tartamudez:** Todos los niños (y adultos) tienen momentos de disfluencia: repetir una palabra, decir "eh...", empezar y parar una frase. Esto es completamente normal. La diferencia con la tartamudez es la frecuencia, la tensión asociada y la duración.

¿Qué pasa en el cerebro?

Investigaciones con neuroimagen han mostrado que las personas que tartamudean presentan diferencias en las conexiones cerebrales entre las áreas encargadas de planificar el habla y las que la ejecutan. Es como si la "autopista" entre el pensamiento y el movimiento de los músculos del habla tuviera un tramo en obras.

Mitos sobre la tartamudez

- **"Tartamudea porque es nervioso":** Falso. La tartamudez tiene una base neurológica. El nerviosismo puede empeorarla, pero no la causa.
- **"Si le digo que respire y hable despacio, se le pasará":** Falso. Estas instrucciones aumentan la ansiedad y empeoran la tartamudez.
- **"Es por un susto o un trauma":** Falso. Aunque el estrés puede ser un desencadenante, la tartamudez tiene una base genética y neurológica.
- **"Se le pasará solo":** A veces sí (muchos niños superan la disfluencia evolutiva), pero no siempre. Si persiste más de 6 meses, conviene consultar.
- **"Los niños que tartamudean son menos inteligentes":** Completamente falso. La tartamudez no tiene ninguna relación con la inteligencia.

> **Dato importante:** La tartamudez tiene un componente genético significativo. Si hay antecedentes familiares, la probabilidad de que un niño tartamudee es mayor, y también es menor la probabilidad de que se resuelva espontáneamente.

CAPÍTULO 2

Evolutiva vs que necesita intervención

No toda disfluencia es tartamudez. Aprende a distinguir cuándo es parte del desarrollo normal y cuándo conviene actuar.

Tabla comparativa

Aspecto	Disfluencia evolutiva	Tartamudez que necesita intervención
Edad	2-5 años (lo más habitual)	Cualquier edad
Tipo de repetición	Palabras o sílabas enteras ("yo-yo-yo quiero")	Sonidos aislados ("y-y-y-yo quiero")
Tensión	No se observa tensión muscular	Tensión visible en cara, cuello o cuerpo
Conciencia	El niño no se da cuenta	El niño es consciente, se frustra
Duración	Menos de 6 meses	Más de 6 meses
Conductas secundarias	No hay	Parpadeo, movimientos de cabeza, evitación de palabras
Evolución	Va y viene, mejora con el tiempo	Se mantiene o empeora
Reacción emocional	No hay o es leve	Ansiedad, vergüenza, evita hablar

Regla orientativa: Si la disfluencia dura más de 6 meses, si observas tensión o lucha al hablar, si el niño evita situaciones de comunicación, o si hay antecedentes familiares de tartamudez, consulta con un logopeda. Mejor consultar de más que de menos.

Las conductas secundarias: una señal de alarma

Las conductas secundarias son movimientos o estrategias que el niño desarrolla de forma involuntaria para intentar "salir" del bloqueo. Son una señal clara de que la tartamudez le está afectando:

- **Parpadeo rápido o cierre de ojos** durante los bloqueos.
- **Movimientos de cabeza** (hacia atrás, hacia los lados) para "empujar" la palabra.
- **Tensión en labios, mandíbula o cuello** visible al hablar.
- **Cambio de palabras:** sustituye la palabra que le bloquea por otra diferente.
- **Evitación:** deja de hablar, responde con monosílabos, no participa en clase.
- **Muletillas:** usa "pues", "eh", "o sea" para tomar impulso antes de la palabra difícil.

Si observas alguna de estas conductas, es importante consultar con un logopeda especializado en fluidez. Las conductas secundarias indican que la tartamudez está consolidándose y que el niño está sufriendo.

CAPÍTULO 3

Factores de riesgo

Conocer los factores de riesgo ayuda a decidir si conviene esperar o actuar.

Factores que aumentan el riesgo de persistencia

No todos los niños que empiezan a tartamudear mantendrán la tartamudez. Los siguientes factores hacen más probable que la disfluencia persista:

1 Antecedentes familiares

Si algún familiar (padres, abuelos, tíos) tartamudea o tartamudeó de niño y no se resolvió, el riesgo de persistencia aumenta significativamente.

2 Sexo masculino

Los niños tienen 3-4 veces más probabilidades que las niñas de tartamudear, y también menos probabilidades de recuperación espontánea.

3 Duración mayor de 6 meses

Cuanto más tiempo lleve el niño tartamudeando, menor es la probabilidad de resolución espontánea.

4 Inicio después de los 3 años y medio

Un inicio más tardío se asocia con mayor riesgo de persistencia.

5 Otras dificultades del habla o lenguaje

Si el niño también tiene dificultades articulatorias o de lenguaje, el riesgo de persistencia aumenta.

6 Severidad creciente

Si la tartamudez va a más en lugar de a menos, es una señal clara de que conviene intervenir.

Importante: Estos factores son orientativos. Un niño puede no tener ningún factor de riesgo y necesitar intervención, o tener varios y resolverlo solo. En caso de duda, consulta siempre.

CAPÍTULO 4

Qué hacer y qué NO hacer

El entorno familiar tiene un papel fundamental. Tu forma de reaccionar puede ayudar enormemente o, sin querer, empeorar la situación.

✓ SÍ hacer

- **Mantén el contacto visual** mientras habla. Que sienta que le escuchas con interés.
- **Escucha con paciencia**, sin prisa. Deja que termine a su ritmo.
- **Habla tú despacio**. Modela un ritmo de habla tranquilo (sin exagerar).
- **Dale tiempo** para terminar. No interrumpas ni completes sus frases.
- **Haz preguntas sencillas** (sí/no, opciones) para reducir la presión.
- **Valora lo que dice**, no cómo lo dice. "Qué historia tan interesante".
- **Crea un ambiente tranquilo** para hablar: sin ruido, sin prisas, sin interrupciones.

✗ NO hacer

- **No le digas "habla despacio"** o "piensa antes de hablar". Aumenta la ansiedad.
- **No termines sus frases**. Aunque creas que le ayudas, le frustra.
- **No apartes la mirada**. Si miras a otro lado, siente que es un problema.
- **No muestres impaciencia**. Nada de suspirar, mirar el reloj o fruncir el ceño.
- **No le hagas repetir**. "Dilo otra vez bien" es contraproducente.
- **No le pongas en evidencia**. Nunca le obligues a hablar en situaciones que le generan ansiedad.
- **No hables de la tartamudez negativamente** delante de él ni con otros cuando pueda oír.

La regla de oro: Lo más importante que puedes hacer es que tu hijo sienta que lo que dice importa más que cómo lo dice. Si se siente escuchado y aceptado, la presión comunicativa disminuye, y con ella, la tartamudez.

Hablar de la tartamudez con tu hijo

Muchos padres evitan hablar de la tartamudez por miedo a empeorarla. Pero si el niño ya es consciente, no hablar de ello le transmite que es algo vergonzoso o que hay que esconder.

- **Si él lo saca:** "A veces las palabras se atascan, ¿verdad? A mucha gente le pasa. No pasa nada."
- **Normaliza:** "A mí también me pasa a veces que no me salen las palabras, sobre todo cuando estoy cansado/a."
- **Empodera:** "Tu cerebro tiene tantas ideas que a veces la boca no va tan rápido. Eso es porque eres muy listo/a."

> **Consejo práctico:** Crea un "momento de hablar" diario: 10 minutos antes de dormir, sin pantallas, sin prisas, donde cada uno cuente algo de su día. Un espacio seguro para comunicarse sin presión.

¿Y los hermanos?

Si hay hermanos, explícales de forma adaptada a su edad que a veces las palabras se atascan y que hay que tener paciencia. No permitas burlas ni imitaciones. Involúcralos como aliados: "Cuando tu hermano/a esté hablando, le esperamos, ¿vale?"

CAPÍTULO 5

Ejercicios de fluidez para casa

Actividades sencillas que podéis hacer en familia para practicar un habla más fluida sin presión.

1 Habla rítmica

Hablar siguiendo un ritmo suave, como si cantaras. Podéis dar palmadas suaves mientras habláis, siguiendo el ritmo de las sílabas. El ritmo externo ayuda al cerebro a organizar la secuencia del habla. Practicad con frases cortas y conocidas.

2 Lectura en coro

Leed juntos, al mismo tiempo, el mismo texto. Cuando hablamos al unísono con otra persona, la tartamudez prácticamente desaparece. Esto le da confianza y la experiencia de hablar sin bloqueos.

3 Canto

Cantad canciones juntos. La tartamudez casi nunca aparece al cantar, porque el canto utiliza circuitos cerebrales diferentes al habla. Además de ser terapéutico, es divertido y crea momentos de conexión familiar.

4 Respiración diafragmática

Poned la mano en la barriga. Inspirad profundamente por la nariz (la barriga se hincha) y soltad el aire despacio por la boca. Practicad varias veces antes de hablar. Una buena respiración es la base de un habla fluida.

5 Habla prolongada

Estirad las vocales al hablar: "Eeeeso eeees uuun gaaato muuuy boooniiiito". Al principio suena exagerado, pero ayuda al cerebro a mantener la continuidad del habla sin bloqueos. Id reduciendo la prolongación gradualmente.

6 Inicio suave

Practicad empezar las frases con un volumen suave, como un susurro que va subiendo. En lugar de "atacar" la primera sílaba con fuerza, se empieza suavemente: "hhhhola, ¿qué tal?". Reduce los bloqueos iniciales.

7 Frases cortas primero

Empezad con frases de 2-3 palabras: "Quiero agua", "Es bonito", "Vamos fuera". Cuando estas salgan fluidas, id alargando: "Quiero un vaso de agua, por favor". Construir éxito desde lo simple.

8 Juego de roles

Jugad a tiendas, al médico, a restaurantes. Las situaciones de juego son menos estresantes que la conversación real y permiten practicar el habla en un contexto divertido y sin presión. Además, el juego simbólico potencia el lenguaje.

Consejos para los ejercicios

- **Hazlo a diario:** 5-10 minutos al día, mejor que una sesión larga a la semana.
- **Hazlo divertido:** si parece terapia, el niño se resistirá. Si parece un juego, querrá repetir.
- **Modela tú primero:** haz el ejercicio tú antes de pedirle que lo haga él.
- **No corrijas:** si tartamudea durante el ejercicio, no pasa nada. El objetivo es practicar, no ser perfecto.
- **Celebra:** "¡Qué bien lo hemos pasado!" es mejor que "¡Qué bien has hablado!".
- **Busca el mejor momento:** cuando esté descansado y relajado, no después de un día agotador.

CAPÍTULO 6

Sección para profesores

Pautas específicas para el entorno escolar. Puedes compartir esta sección con los profesores de tu hijo/a.

Pautas para el aula

1 No forzar la lectura en voz alta

Nunca obligar a leer en voz alta delante de la clase. Si quiere participar, ofrecerle la opción, pero sin presionar. Puede leer en voz alta al profesor en privado si lo prefiere.

2 Darle tiempo

Cuando le preguntes, dale tiempo extra para responder. No mires el reloj ni muestres impaciencia. Si ves que se bloquea, reformula la pregunta de forma más sencilla.

3 No interrumpir ni completar

Dejar que termine a su ritmo, aunque tarde. Completar sus frases le transmite que su forma de hablar es un problema.

4 No evaluar la fluidez

Si tiene que hacer una exposición oral, evaluar el contenido, la preparación y la creatividad, nunca la fluidez del habla.

5 Ubicación en el aula

Sentarle donde se sienta cómodo (no necesariamente en primera fila). Preguntarle en privado dónde prefiere sentarse.

6 Conversación privada

Hablar con el alumno en privado sobre sus necesidades. Preguntarle qué le ayuda y qué le resulta difícil. Hacerle partícipe de las decisiones.

7 Adaptar las presentaciones orales

Ofrecer alternativas: presentar en grupo, grabar un vídeo, hacer una presentación con apoyo visual donde hable menos, o presentar solo ante el profesor.

Crear un aula segura

Más allá de las pautas individuales, es fundamental crear un clima de aula donde la diversidad comunicativa sea respetada:

- Trabajar el **respeto a los turnos de habla** con todos los alumnos.
- No tolerar **burlas ni imitaciones**. Intervenir inmediatamente si ocurren.
- Incorporar actividades de **educación emocional** que trabajen la empatía.
- Si el alumno lo desea, hablar con la clase sobre la tartamudez de forma **normalizada**.

> **Para el profesor:** Un niño que tartamudea puede tener mucho que aportar. No le definas por su tartamudez. Busca sus fortalezas y poténcialas. Tu actitud marcará la diferencia entre un alumno que se apaga y uno que florece.

CAPÍTULO 7

Cuándo consultar

Señales claras de que es momento de buscar ayuda profesional.

Consulta con un logopeda si...

- La tartamudez dura más de 6 meses.
- El niño se muestra frustrado, triste o enfadado por su forma de hablar.
- Observas tensión visible (en cara, cuello o cuerpo) al hablar.
- El niño evita hablar, responde con monosílabos o deja de participar.
- Aparecen conductas secundarias: parpadeo, movimientos de cabeza, muletillas.
- La tartamudez va a más en lugar de a menos.
- Hay antecedentes familiares de tartamudez persistente.
- El niño tiene más de 5 años y sigue tartamudeando.
- Otros niños se burlan o el niño sufre socialmente.
- Tú, como padre/madre, estás preocupado/a. Tu instinto importa.

> **¿Qué hará el logopeda?** Evaluará el tipo y la severidad de la tartamudez, los factores de riesgo, el impacto emocional y comunicativo. A partir de ahí, diseñará un plan de intervención que puede incluir: trabajo directo con el niño, pautas para la familia, coordinación con el colegio y seguimiento.

¿Cuánto dura la intervención?

Depende de cada caso. Algunos niños mejoran significativamente en pocos meses; otros necesitan un seguimiento más largo. Lo importante es que la intervención temprana tiene los mejores resultados: cuanto antes se empiece, más probable es la recuperación completa.

CAPÍTULO 8

Recursos y bibliografía

Lecturas, webs y materiales para seguir aprendiendo sobre tartamudez infantil.

Libros recomendados

- "*Tartamudez: guía para padres*" – Fundación Española de la Tartamudez. Práctico y accesible.
- "*El niño que tartamudea*" – J. Scott Yaruss & Nina Reardon-Reeves. Una guía para familias basada en evidencia.
- "*Stuttering: Foundations and Clinical Applications*" – Ehud Yairi & Carol Seery. Referencia académica completa.

Webs y asociaciones

- **Fundación Española de la Tartamudez (TTM):** fundacionttm.org
- **The Stuttering Foundation:** stutteringhelp.org (en inglés y español)
- **ISAD (International Stuttering Awareness Day):** isastutter.org
- **Asociación Española de Tartamudez:** recursos y grupos de apoyo.

Para niños

- "*El tartamudo*" – Cuento infantil para normalizar la tartamudez.
- "*A veces las palabras se atascan*" – Libro ilustrado para niños que tartamudean.
- Vídeos de personas famosas que tartamudean: Ed Sheeran, Joe Biden, Emily Blunt.

Películas y documentales

- "*El discurso del rey*" (2010) – La historia del rey Jorge VI y su tartamudez.
- "*Rocket Science*" (2007) – Un adolescente con tartamudez se une al equipo de debate.

Carta a las familias

La tartamudez puede generar preocupación, frustración y a veces culpa. Queremos decirte algo importante: **no es culpa tuya**, y hay mucho que puedes hacer para ayudar.

Tu hijo/a necesita sentir que **lo que dice importa más que cómo lo dice**. Necesita un hogar donde hablar sea seguro, donde no haya prisa ni juicio.

Con el apoyo adecuado, la mayoría de los niños mejoran significativamente. Y los que mantienen cierto grado de tartamudez pueden aprender a comunicarse con confianza y sin miedo.

En **Espacio Lenguaje** estamos especializados en fluidez infantil. Si necesitas orientación, estamos a tu lado.

Tu hijo/a tiene voz. Ayúdale a usarla.

espaciolenguaje.com

Logopedia infantil especializada

Espacio Lenguaje

Logopedia infantil especializada.
Recursos, guías y acompañamiento profesional para familias y educadores.

espaciolenguaje.com